

内科学名词解释、问答

- 1、**慢支**：是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以咳嗽、咳痰为主要症状，或有喘息，每年发病持续3个月或更长时间，连续2年或2年以上，并排除具有咳嗽、咳痰、喘息症状的其他疾病。
- 2、**COPD：慢阻肺**，是以持续气流受限为特征的可以预防和治疗疾病，其气流受限多呈进行性发展，与气道和肺组织对香烟烟雾等有害气体或有害颗粒的异常慢性炎症反应有关。
- 3、**AECOPD**：慢阻肺急性加重，是指咳嗽、咳痰、呼吸困难比平时加重或痰量增多，或咳黄痰，或者是需要改变用药方案。
- 4、**支气管哮喘**：是由多种细胞（如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞、中性粒细胞、平滑肌细胞、气道上皮细胞等）和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病。主要特征包括气道慢性炎症，气道对多种刺激因素呈现的高反应性，广泛多变的可逆性气道受限以及随病程延长而导致的一系列气道结构的改变，即气道重塑。临床表现为反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状，常在夜间及凌晨发作或加重，多数患者可自行缓解或经治疗后缓解。
- 5、**AHR：气道高反应性**，是指气道对各种刺激因子如变应原、理化因素、运动、药物等呈现的高度敏感状态，表现为患者接触这些刺激因子时气道出现过强或过早的收缩反应，它是哮喘的基本特征。
- 6、**CAP：社区获得性肺炎**，指在医院外患的感染性肺实质炎症，包括具有明确潜伏期的病原体感染而入院后在平均潜伏期内爆发的肺炎。
- 7、**HAP：医院获得性肺炎**，是指患者入院时不存在、也不处于潜伏期，而入院48小时后在医院（包括老年护理院、康复院等）内发生的肺炎。
- 8、**Koch现象**：将结核分枝杆菌皮下注射到未感染的豚鼠，10~14日后局部皮肤红肿、溃烂，形成深的溃疡，不愈合，最后豚鼠因结核分枝杆菌播散到全身而死亡。而对3~6周前受少量结核分枝杆菌感染和结核菌素皮肤试验阳转的动物，给予同等剂量的结核分枝杆菌皮下注射，2~3日后局部出现红肿，形成表浅溃烂，继之较快愈合，无淋巴结肿大，无播散和死亡。这种机体对结核分枝杆菌再感染和初感染所表现出不同反应的现象称为~。
- 9、**原发综合征**：原发性肺结核时，肺部原发病灶、淋巴管炎和肺门淋巴结结核称为~，原发病灶一般吸收较快，可不留任何痕迹，X线呈哑铃状阴影。
- 10、**中央型肺癌**：发生在段支气管至主支气管的肺癌称中央型肺癌，约占3/4，较多见鳞状上皮细胞癌和小细胞肺癌。X线表现为支气管阻塞，阻塞不完全时呈现段、叶局限性气肿；完全阻塞时，表现为段、叶不张；肺不张伴有肺门淋巴结肿大时，下缘可表现为倒S征。
- 11、**周围型肺癌**：发生在段支气管一下的肺癌称周围型肺癌，约1/4，多见腺癌。X线表现为圆形或类圆形，边缘常呈分叶状，伴有脐凹或细毛刺。
- 12、**上腔静脉阻塞综合征**：上腔静脉被附近肿大的转移性淋巴结压迫或右上肺的原发性肺癌侵犯，以及腔静脉内癌栓阻塞静脉回流引起，表现为头面部和上半身淤血水肿，颈部肿胀，颈静脉扩张，患者常主诉领口进行性变紧，可在前胸壁见到扩张的静脉侧支循环。
- 13、**Pancoast瘤/Horner综合征**：肺尖部肺癌，易压迫颈部交感神经，引起患侧瞳孔缩小、眼裂变浅、上睑下垂、眼球内陷，同侧额部与胸壁少汗或无汗。也常有肿瘤压迫臂丛神经，造成以腋下为主、向上肢内侧放射的火灼样疼痛，在夜间尤甚。
- 14、**副癌综合征**：肺癌非转移性胸外表现，主要表现为肥大性肺性骨关节病、异位促性腺激素、分泌促肾上腺皮质激素样物、分泌抗利尿激素、神经肌肉综合征、高钙血症、类癌综合征。
- 15、**类癌综合征**：肺癌非转移性胸外表现，类癌综合征的典型特征是皮肤、心血管、胃肠道和呼吸功能异常。主要表现为面部、上肢躯干的潮红或水肿，胃肠蠕动增强，腹泻，心动过速，喘息，瘙痒和感觉异常。与肿瘤释放不同的血管活性物质有关，5-羟色胺、缓激肽、血管舒缓素和儿茶酚胺。
- 16、**ILD：间质性肺疾病**，是一组主要累及肺间质和肺泡腔，导致肺泡-毛细血管功能单位丧失的弥漫性肺疾病。主要表现为进行性加重的呼吸困难、限制性通气障碍伴弥散功能降低、低氧血症，影像学上表现为双肺弥漫性疾病。最终可发展为弥漫性肺纤维化、蜂窝肺，导致呼吸衰竭而死亡。

- 17、**结节病**：是一种原因不明的多系统累及的肉芽肿性疾病，主要侵犯肺和淋巴系统，其次是眼部和皮肤。
- 18、***肺出血—肾炎综合征**：由于病毒感染、吸入化学物质（烃或一氧化碳）等因素，引发机体产生抗肾小球基底膜抗体和抗肺泡毛细血管基底膜抗体，通过自身免疫机制损伤肾小球和肺泡毛细血管基底膜，引发以肺弥漫性出血、肺泡内纤维素沉着和肾小球肾炎为特征的综合征。
- 19、**肺动脉高压**：是由多种已知或未知原因引起的肺动脉异常升高的一种病理生理状态，血流动力学诊断标准为在海平面、静息状态下，右心导管测量平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$
- 20、**肺心病**：由支气管-肺组织、胸廓或肺血管病变致肺血管阻力增加，产生肺动脉高压，继而右心室结构、功能改变的疾病。根据起病缓急和病程长短，可分为急性和慢性肺心病两类。
- 21、**Hamman 征**：大量气胸时，气管向健侧移位，患侧胸部隆起，呼吸运动与触觉语颤减弱，叩诊呈过清音或鼓音，心或肝浊音界缩小或消失，听诊呼吸音减弱或消失。左侧少量气胸或纵隔气肿时，有时可在左心缘处听到与心跳一致的气泡破裂音，称~。
- 22、***SAHS**：睡眠呼吸暂停低通气综合征，多种原因导致睡眠状态下反复出现呼吸暂停、低通气，引起间歇性低氧血症伴高碳酸血症，以及睡眠结构紊乱，进而使机体发生一系列病理生理改变的临床综合征。主要表现为睡眠打鼾伴呼吸暂停及日间嗜睡、疲乏等。
- 23、***ARDS**：急性呼吸窘迫综合征，由各种肺内和肺外致病因素所导致的急性弥漫性肺损伤和进而发展的急性呼吸衰竭。主要病理特征是炎症导致的肺微血管通透性增高，肺泡腔渗出富含蛋白质的液体，进而导致肺水肿及透明膜形成，常伴有肺泡出血。主要病理生理改变是肺容积减少、肺顺应性降低和严重通气/血流比例失调。临床表现为呼吸窘迫、顽固性低氧血症、呼吸衰竭，肺部影像学表现为双肺渗出性病变。
- 24、**呼吸衰竭**：各种原因引起的肺通气、换气功能严重障碍，使静息状态下亦不能维持足够的气体交换，导致低氧血症，伴不伴有高碳酸血症，进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征。
- 25、**I 型呼吸衰竭**：低氧性呼吸衰竭，血气分析特点是 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， PaCO_2 降低或正常。主要见于肺换气障碍（通气/血流比例失调、弥散功能损害和肺动-静脉分流）疾病，如严重肺部感染性疾病、间质性肺疾病、急性肺栓塞等。
- 26、**II 型呼吸衰竭**：高碳酸性呼吸衰竭，血气分析特点是 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ，同时伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 。系肺泡通气不足所致。单纯通气不足，低氧血症和高碳酸血症的程度是平行的，若伴有换气功能障碍，则低氧血症更为严重，如 COPD。
- 27、**肺性脑病/CO₂ 麻醉**：CO₂ 潴留达到 $\text{PaCO}_2 \geq 80\text{mmHg}$ 时，可引起头痛、头晕、烦躁不安、言语不清、精神错乱、扑翼样震颤、嗜睡、昏迷、抽搐、呼吸抑制等表现，这种由缺氧和 CO₂ 储留所致的神经精神障碍症候群。
- 28、**HF：心力衰竭**，是各种心脏结构或功能性疾病导致心室充盈、射血能力受损，心排血量不能满足机体代谢的需要，器官、组织血液灌注不足，以肺循环、体循环淤血，器官、组织血液灌注不足为临床表现的一组综合征，主要表现为呼吸困难、体力活动受限、体液储留。
- 29、**心室重塑**：在心脏功能受损，心腔扩大、心肌肥厚的代偿过程中，心肌细胞、胞外基质、胶原纤维网等均发生相应变化，即~，是心力衰竭发生发展的基本病理机制。
- 30、**心律失常**：心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度、激动次序的异常。按其发生原理，可分为冲动形成异常、冲动传导异常；按其发生时心率的快慢，可分为快速性、缓慢性心律失常。
- 31、**期前收缩**：起源于窦房结以外的异位起搏点提前发出的激动，是临床上最常见的心律失常。根据异位起搏发生的部位，可分为房性、交界性、室性；产生机制包括折返激动、触发活动、异位起搏点的兴奋性提高。
- 32、**折返**：折返是快速心律失常的最常见发生机制。产生折返的基本条件是传导异常，包括：
- ①心脏两个或多个部位的传导性与不应期各不相同，相互连接形成一个闭合环；
 - ②其中一条道发生单向传导阻滞；
 - ③另一通道传导缓慢，使原先发生阻滞的通道有足够时间恢复兴奋性；
 - ④原先阻滞的通道再次激动，从而完成一次折返激动。
- 冲动在环内反复循环，产生持续而快速的心律失常。

- 33、*Adams-Stokes 综合征：心源性脑缺血综合征，是指突然发作的严重的、致命性缓慢性或快速性心律失常，使心排出量在短时间内锐减，产生黑蒙、短暂意识障碍、晕厥等症状，称~，与体位改变无关。
- 34、SSS：病态窦房结综合征，是由窦房结病变导致功能减退，产生多种心律失常的综合表现。患者可在不同时间出现一种以上的心律失常，常同时合并心房自律性异常，部分患者同时有房室传导功能障碍。
- 35、预激综合征/WPW 综合征：在正常的房室结特殊传导组织外，沿房室环周围还存在一些由普通工作心肌组成的附加的房室传导束，包括房室旁路、房-希氏束、结室纤维、分支室纤维。心电图呈预激表现，临床上有心动过速发作。心电图的预激是指心房冲动提前激动心室的一部分或全体。
- 36、室性早搏：希氏束分叉以下部位过早发生的，提前使心肌除极的心搏。心电图表现为：
①提前出现的 QRS 波前常无相关 P 波；
②提前出现的 QRS 波，时限通常超过 0.12s，ST 段与 T 段的方向与 QRS 波主波方向相反；
③配对间期恒定；
④代偿间歇往往完全。
- 37、CHD：冠心病，冠状动脉粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞，导致心肌缺血缺氧甚至坏死而引起的心脏病，也称缺血性心脏病。
- 38、ACS：急性冠脉综合征，由于冠脉内斑块破裂，促发血栓形成或血管痉挛所致的严重心脏缺血而产生的一组临床综合征，包括不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高性心肌梗死、ST 段抬高性心肌梗死，也有将冠心病猝死也包括在内。
- 39、稳定性心绞痛：劳力性心绞痛，是在冠状动脉固定性严重狭窄的基础上，由于心肌负荷的增加引起心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧的临床综合征。其特点为阵发性的前胸压榨性疼痛或憋闷感觉，主要位于胸骨后部，可放射至心前区和左上肢尺侧，常发生于劳力负荷增加时，休息或用硝酸酯制剂后消失。
- 40、STEMI(急性 ST 段抬高性心肌梗死)/AMI(急性心肌梗死)：
是指急性心肌缺血性坏死，大多是在冠脉病变的基础上，发生冠脉血供急剧减少或中断，使相应的心肌严重而持久地急性缺血所致。通常原因是在冠脉不稳定斑块破裂、糜烂的基础上继发血栓形成，导致冠状动脉血管持续、完全闭塞。基本病因是冠脉粥样硬化。
- 41、变异型心绞痛：血管痉挛性心绞痛，在静息情况下，无体力劳动或情绪激动等诱因发生的，常伴随一过性 ST 段抬高或压低的冠脉痉挛。是不稳定型心绞痛的一种特殊类型。临床表现为不与冠脉狭窄程度成正比，麦角新碱或乙酰胆碱可诱发。
- 42、心肌梗死后遗症：心肌梗死后数周至数月内出现的、可反复发生的心包炎、胸膜炎、肺炎，有发热、胸痛等症状，可能为机体对坏死物质的过敏反应。
- 43、再灌注心肌治疗：起病 3~6 小时，最多在 12 小时内，使闭塞的冠脉再通，心肌得到再灌注，濒临坏死的心肌可能得以存活或使坏死范围缩小，减轻梗死后心肌重塑，预后改善，是一种积极的治疗措施。
- 44、*胰岛素抵抗：指胰岛素作用的靶器官（主要是肝脏、肌肉和脂肪组织）对胰岛素作用的敏感性降低。机体必须以高于正常的血胰岛素释放水平来维持正常的糖耐量，表示机体组织对胰岛素处理葡萄糖的能力减退。
- 45、高血压急症：原发性或继发性高血压患者，在某些诱因作用下，血压突然和明显升高（一般超过 180/120mmHg），伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现。
- 46、恶性高血压：少数高血压患者病情急骤发展，舒张压持续 ≥ 130 mmHg，并有头痛，视力模糊，眼底出血、渗出、视盘水肿，肾脏损害突出，持续蛋白尿、血尿、管型尿的表现。
- 47、高血压亚急症：高血压患者血压明显升高但不伴严重临床症状及进行性靶器官损害，患者可有明显升高造成的头痛、胸闷、鼻出血、烦躁不安。
- 48、继发性高血压：由某些确定的疾病或病因引起的血压升高，如原发性醛固酮增多症、嗜铬细胞瘤、肾血管性高血压、肾素分泌瘤等，可通过手术得到根治或改善。及早明确诊断能明显提高治愈率及阻止病情进展。

- 49、**肾实质性高血压**：包括急、慢性肾小球肾炎，糖尿病性肾病、慢性肾盂肾炎，多囊肾和肾移植后等多种肾脏病变引起的高血压，是最常见的继发性高血压。其发生主要由于肾单位大量丢失，导致水钠潴留和细胞外容量增加，以及肾脏 RAAS 激活与排钠激素减少。高血压又进一步升高肾小球内囊压力，形成恶性循环，加重肾脏病变。
- 50、**DCM**：扩张型心肌病，以左心室或双心室扩大版收缩功能障碍为特征的心肌病，临床表现为心脏扩大、心力衰竭、心律失常、血栓栓塞、猝死。
- 51、**HCM**：**肥厚性心肌病**，是以左心室、右心室非对称性肥厚为特征，并累及室间隔，左心室血液充盈受阻、舒张期顺应性下降为基本病态的心肌病，根据左心室流出道有无梗阻又可分为梗阻性肥厚型和非梗阻型心肌病，是青少年运动猝死的最重要原因之一。
- 52、**限制型心肌病**：是以心室壁僵硬增加、舒张功能降低、充盈受限而产生的临床右心衰为特征的心肌病。患者心房明显扩张，但早期左心室不扩张，收缩功能多正常，室壁不增厚或仅轻度增厚。
- 53、**心瓣膜病**：炎症、粘液样变、退行性变、先天性畸形、缺血性坏死、创伤等原因引起的单个或多个瓣膜结构（包括瓣叶、瓣环、腱索、乳头肌）的功能或结构异常，导致瓣口狭窄和（或）关闭不全。瓣膜狭窄，使心腔压力负荷增加；瓣膜关闭不全，使心腔容量负荷增加。
- 54、**Graham—Steel 杂音**：严重肺动脉高压时，由于肺动脉及其瓣环的扩张，导致相对性肺动脉瓣关闭不全，因而在胸骨左缘第 2 肋间可闻及递减型高调叹气样舒张早期杂音。
- 55、**Austin—Flint 杂音**：主动脉瓣严重反流时，左心室血容量增多及舒张期压力增高，将二尖瓣前叶推至较高位置引起相对性二尖瓣狭窄，同时，反流血液与由左心房流入的血液发生冲击、混合，产生涡流，因而在在心尖区闻及柔和低调性隆隆样舒张期杂音。
- 56、**Beck 三联征**：心包疾患或其他病因累及心包可以造成心包渗出和心包积液，当积液迅速或积液量达到一定程度时，可造成心脏输出量和回心血量明显下降而产生临床症状，即心包填塞，其典型临床症状为低血压、心音遥远、颈静脉怒张，即~。
- 57、**Ewart 征**：心包填塞有大量积液时，可在左肩胛骨下出现叩浊音，听诊闻及支气管呼吸音，称心包积液征，即~，此乃肺组织受压所致。
- 58、**Kussmaul 征**：缩窄性心包炎时，由于吸气时，周围静脉回流增多，而已缩窄的心包使心室无法适应性扩张，致使吸气时颈静脉压进一步升高，静脉扩张更明显，称~。
- 59、**GERD**：**胃食管反流病**，胃十二指肠内容物反流入食管引起烧心等症状，根据是否导致食管黏膜糜烂、溃疡，分为反流性食管炎及非糜烂性反流病。**GERD** 也可引起咽喉、气道等食管邻近的组织损害，出现食管外症状。
- 60、***TLESR**：一过性 LES 松弛，非吞咽情况下 LES 的自发性松弛，其松弛时间明显长于吞咽时 LES 松弛的时间。它既是正常人生理性胃食管反流的主要原因，也是 LES 静息压正常的胃食管反流病者的主要发病机制。
- 61、**Barrett 食管**：食管下段鳞状上皮被化生的柱状上皮所替代称之为~，多发生于胃食管连接处的齿状线近端。内镜下的表现为正常呈现均匀粉红带灰白的食管黏膜出现胃黏膜的橘红色，分布可为环形、舌形或岛状。**Barrett 食管**可发生在反流性食管炎的基础上，亦可不伴有反流性食管炎。**Barrett 食管**是食管腺癌的癌前病变。
- 62、***Curling 溃疡**：严重创伤、大手术、大面积烧伤、颅内病变、败血症及其他严重脏器病变或多器官功能衰竭等均可引起胃黏膜糜烂、出血，严重者发生急性溃疡并大量出血，称为应激性溃疡，如烧伤所致者称 **Curling 溃疡**。
- 63、***Cushing 溃疡**：严重创伤、大手术、大面积烧伤、颅内病变、败血症及其他严重脏器病变或多器官功能衰竭等均可引起胃黏膜糜烂、出血，严重者发生急性溃疡并大量出血，称为应激性溃疡，中枢神经系统病变所致者称 **Cushing 溃疡**。
- 64、**PU**：**消化性溃疡**，指胃肠道粘膜被自身消化而形成的溃疡，可发生于食管、胃、十二指肠、胃-空场吻合口附近以及含有胃黏膜的 **Meckel 憩室**。以胃、十二指肠球部溃疡最为常见。
- 65、**复合溃疡**：指胃和十二指肠均有活动性溃疡，男性多见，幽门梗阻发生率较高。复合溃疡中的胃溃疡较单独的胃溃疡癌变率低。
- 66、**幽门管溃疡**：餐后很快发生疼痛，早期出现呕吐，易出现幽门梗阻、出血和穿孔等并发症。

- 67、**球后溃疡**：发生在球部远端十二指肠的溃疡称为球后溃疡，多发生在十二指肠降段的初始部及乳头附近，溃疡多在后内侧壁，可穿透入胰腺。疼痛可向右上腹及背部放射。易出血，严重的炎症反应可导致胆总管引流障碍，出现梗阻性黄疸或引发急性胰腺炎。
- 68、**巨大溃疡**：指直径大于 2cm 的溃疡。常见于有 NSAIDs 服用史及老年患者。巨大十二指肠球部溃疡常在后壁，易发展为穿透性，周围有大的炎性团块，疼痛剧烈而顽固，多放射至背部。巨大胃溃疡并不都是恶性的。
- 69、***穿透性溃疡**：十二指肠或胃后壁的溃疡深至浆膜层时已与邻近的组织或器官发生粘连，穿孔时胃肠内容物不流入腹腔，称为慢性穿孔，又称为～。这种溃疡改变了腹痛规律，变得顽固而持续。疼痛常放射至背部。
- 70、**胃泌素瘤/卓艾综合征**：由促胃液素瘤或促胃液素细胞增生所致，临床上以高胃酸分泌，血促胃液素水平升高，多发、顽固及不典型部位消化性溃疡及腹泻为特征。多数溃疡位于十二指肠球部、胃小弯侧。
- 71、**X 线钡餐激惹征**：溃疡型肠结核行 X 线钡剂灌肠时，钡剂于病变肠段呈现激惹征象，排空很快，充盈不佳，而在病变的上、下肠段则钡剂充盈良好，称为～。病变肠段如能充盈，则显示黏膜皱襞粗乱、肠壁边缘不规则，有时呈锯齿状，可见溃疡。也可见肠腔变窄、肠段缩短变形、回肠盲肠正常角度消失。
- 72、**IBD：炎症性肠病**，是一类多种病因引起的、异常免疫介导的肠道慢性及复发性炎症，有终生复发倾向，包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。
- 73、**UC**：溃疡性结肠炎，是一种病因尚不十分清楚的直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病。病变主要限于大肠黏膜与黏膜下层。临床表现为腹泻、黏液脓血便、腹痛。病情轻重不等，多呈反复发作的慢性病程。
- 74、**CD**：克罗恩病，是一种慢性炎性肉芽肿性疾病，多见于末段回肠和邻近结肠，但从口腔至肛门各段消化道均可受累，呈节段性或跳跃式分布。临床上以腹痛、腹泻、体重下降、腹块、瘻管形成和肠梗阻为特点，可伴有发热等全身表现以及关节、皮肤、眼、口腔黏膜等肠外损害。重症者迁延不愈，预后不良。
- 75、**IBS**：肠易激综合征，是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征而无器质性病变的功能性肠病。本病是最常见的一种功能性肠道疾病，患者以中青年居多，50 岁以后首次发病少见。男女比例约 1:2。
- 76、**肝硬化**：是一种或多种原因引起的、以肝组织弥漫性纤维化、假小叶和再生结节为组织学特征的进行性慢性肝病。早期无明显症状，后期因肝脏变形硬化、肝小叶结构和血液循环途径显著改变，临床以肝功能减退和门静脉高压为特征，常并发上消化道出血、肝性脑病、继发感染等而死亡。
- 77、**EGVB：食管胃底静脉曲张出血**，肝硬化门静脉高压是其破裂出血最主要原因，诱因多见于粗糙食物、胃酸侵蚀、腹内压增高、剧烈咳嗽。临床表现为突发大量呕血或柏油样便，伴出血性休克。
- 78、**急性出血性糜烂性胃炎**：门静脉高压使胃黏膜静脉回流缓慢，胃十二指肠的上皮后机制削弱，大量代谢产物淤滞于黏膜，屏障功能受损，黏膜糜烂、溃疡甚至出血。
- 79、**门静脉高压性胃病**：是胃黏膜下的动-静脉交通支广泛开放胃黏膜毛细血管扩张，广泛渗血。临床多为反复或持续少量呕血、黑便及难以纠正的贫血，少数出现上消化道大出血。
- 80、**SBP：自发性细菌性腹膜炎**，因非腹内脏器感染引发的急性细菌性腹膜炎。由于腹水是细菌的良好培养基，肝硬化患者出现腹水后容易导致该病，致病菌多为 G-。起病缓慢者多有低热、腹胀或腹水持续不减；病情进展快者，腹痛明显、腹水增长迅速，严重者诱发肝性脑病、出现中毒性休克等。体检发现轻重不等的全腹压痛和腹膜刺激征。腹水外观浑浊，生化及镜检提示为渗出性，腹水可培养出致病菌。
- 81、**HRS：肝肾综合征**，是指发生在严重肝病基础上的肾衰竭，但肾脏本身并无器质性损害，故又称功能性肾衰竭。主要见于伴有腹水的晚期肝硬化或急性肝功能衰竭患者。发病机制主要是全身血流动力学的改变，表现为内脏血管床扩张，心输出量相对不足和有效血容量不足，肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经系统被进一步激活，最终导致肾皮质血管强烈收缩、肾小球滤过率下降。临床主要表现为少尿、无尿及氮质血症。

- 82、**HPS**：肝肺综合征，在排除原发心肺疾患后，具有基础肝病、肺内血管扩张和动脉血氧合功能障碍的三联征。临床上主要表现为肝硬化伴呼吸困难、发绀和杵状指(趾)，预后较差。肺内血管扩张可通过胸部 CT 及肺血管造影显示。慢性肝病患者具有严重低氧血症($\text{PaO}_2 < 6.7\text{kPa}$)应疑诊； $\text{PaO}_2 < 10\text{kPa}$ 是诊断肝肺综合征的必备条件。
- 83、**顽固性腹水**：当对肝硬化患者饮食限钠和使用大剂量利尿剂（螺内酯 400mg/d 和呋塞米 160mg/d）时，腹水仍不能缓解，在治疗性腹腔穿刺术后迅速复发，称为~。对于利尿剂使用虽未达最大剂量，腹水无减退且反复诱发肝性脑病、低钠血症、高钾血症或高氮质血症者亦被视为顽固性腹水。
- 84、**原发性肝癌**：是指由肝细胞或肝内胆管上皮细胞发生的恶性肿瘤，其死亡率在消化系统恶性肿瘤中居第二位，本病多见于中年男性，男女之比为 5:1。乙肝后肝硬化癌变是最主要的发病机制，以肝细胞肝癌最为多见。
- 85、**小肝癌**：单个癌结节直径小于 3cm 或相邻两个癌结节直径之和小于 3cm 者称为小肝癌。
- 86、**伴癌综合征**：伴癌综合征指原发性肝癌患者由于癌肿本身代谢异常或癌组织对机体影响而引起内分泌或代谢异常的一组症候群。主要表现为自发性低血糖症、红细胞增多症；其他罕见的有高钙血症、高脂血症、类癌综合征等。
- 87、***亚临床肝癌**：AFP 检出但无任何临床症状和体征的肝癌。
- 88、**HE**：**肝性脑病**，也称肝昏迷，是严重肝病或门-体分流引起的以代谢紊乱为基础、中枢神经系统功能失调的综合征，临床表现轻者可仅有轻微的智力减退，严重者出现意识障碍、行为失常和昏迷。
- 89、**轻微肝性脑病**：患者无行为、性格的异常，无神经系统病理征，脑电图正常，且可从事日常生活和工作，只在心理测试或智力测试时有轻微异常，这些患者的反应力常降低，不宜驾车及高空作业。
- 90、**急性胰腺炎**：是多种病因导致胰腺组织自身消化所致的胰腺水肿、出血、坏死等炎性损伤。临床以急性上腹痛及血淀粉酶或脂肪酶升高为特点。我国最常见病因胆石症，最常见诱因是暴饮暴食。
- 91、**Grey—Turner 征**：重症急性胰腺炎患者可因胰酶、坏死组织及出血沿腹膜间隙与肌层渗入腹壁下，致两侧胁腹部皮肤呈暗灰蓝色，称 Grey-Turner 征
- 92、**Cullen 征**：重症急性胰腺炎患者可因胰酶、坏死组织及出血致脐周围皮肤青紫，称 Cullen 征。
- 93、**上消化道出血**：是指从食管到屈氏韧带之间消化道的出血，是消化系统常见的病症。其四大病因是消化性溃疡、食管胃底静脉曲张破裂、急性糜烂出血性胃炎和胃癌。轻者可无症状，临床表现多为呕血、黑便或等，少有血便，伴有贫血及血容量减少，甚至休克，严重者危及生命。
- 94、***应激相关性胃黏膜损伤**：各种严重疾病引起的应激状态下产生的急性糜烂出血性胃炎乃至溃疡形成统称为~，可发生出血，发生大出血以溃疡形成时多见。
- 95、**OGIB**：不明原因消化道出血，是指全胃肠镜检（胃、结肠镜、胶囊胃镜）不能明确病因的、持续或反复发作的出血。

慢阻肺

1、慢阻肺患者气道受限严重程度的肺功能分级

肺功能分级	患者肺功能
GOLD 1级：轻度	FEV1/FVC<70%，FEV1%pred≥80%，有或无慢性咳嗽、咳痰
GOLD 2级：中度	FEV1/FVC<70%，50%≤FEV1%pred<80%，常伴有慢性咳嗽、咳痰、活动后呼吸困难
GOLD 3级：重度	FEV1/FVC<70%，30%≤FEV1%pred<50%，多伴有慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难，反复出现急性加重
GOLD 4级：极重度	FEV1/FVC<70%，FEV1%pred<30%或FEV1%pred<50%伴慢性呼衰，可合并肺心病及右心功能不全或衰竭

2、慢阻肺急性加重期的治疗

- ①确定急性加重期的原因及病情严重程度，根据病情严重程度决定门诊或住院治疗，最多见的急性加重原因是细菌或病毒感染
- ②支气管舒张药：SABA、LABA、抗胆碱能药（异丙托溴胺、噻托溴胺）、茶碱类
- ③低流量吸氧：一般吸入氧浓度为 28%~30%
- ④抗生素：当患者呼吸困难加重，咳嗽伴痰量增加、有脓性痰时，应根据患者所在地常见病原菌类型及药物敏感情况积极选用抗生素治疗
- ⑤糖皮质激素
- ⑥祛痰剂：溴己新、盐酸氨溴索。

支气管哮喘

3、支气管哮喘的诊断标准

- (1)反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽，多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关
- (2)发作时在双肺可闻及散在或弥漫性，以呼气相为主的哮鸣音，呼气相延长
- (3)上述症状可经平喘药物治疗缓解或自行缓解
- (4)除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽
- (5)临床症状不典型者（如无明显喘息或体征）应有下列三项中至少一项阳性：
 - ①支气管激发实验或运动试验阳性
 - ②支气管舒张试验阳性
 - ③昼夜 PEF 变异率≥20%

符合 1~4 条或 4、5 条者，可以诊断为支气管哮喘

4、心源性哮喘与支气管哮喘的鉴别诊断

	心源性哮喘	支气管哮喘
病史	无	有
年龄	中老年	青少年
既往史	高血压、冠心病、风湿性心脏病	过敏史
症状	起病急、端坐呼吸、阵发性咳嗽、咳粉红色泡沫痰	白色黏液痰
体征	左心界扩大、心率增快、奔马律、肺部广泛湿啰音和哮鸣音	肺部广泛哮鸣音
BNP	>400pg/ml	<400pg/ml
X 线	心脏增大、肺淤血	发作时肺透亮度增加，缓解期无明显异常
药物	氨茶碱、吗啡	氨茶碱
禁用	肾上腺素	肾上腺素、吗啡

5、支气管哮喘的药物治疗

- ①糖皮质激素：目前控制哮喘最有效的药物
吸入：倍氯米松、布地奈德
口服：泼尼松、泼尼松龙
静脉：琥珀酸氢化可的松、甲泼尼龙
- ② β_2 受体激动剂：SABA（控制急性发作首选）：沙丁胺醇、特布他林
LABA（与ICS联合是目前最常用的哮喘控制性药物）：沙美特罗、福莫特罗
- ③白三烯调节剂：孟鲁司特、扎鲁司特
- ④茶碱类药物：口服：氨茶碱、缓释茶碱
静脉：氨茶碱
- ⑤抗胆碱药：SAMA（控制急性发作）：异丙托溴胺
LAMA：噻托溴胺
- ⑥抗IgE抗体

6、重度至危重度哮喘的目的及处理原则

目的：尽快缓解气道痉挛，纠正低氧血症，恢复肺功能，预防进一步恶化或再次发作，防止并发症

- (1) 持续雾化吸入 SABA，联合雾化吸入 SAMA、激素混悬液以及静脉茶碱类药物
- (2) 吸氧
- (3) 尽早静脉应用激素，待病情得到控制和缓解后改为口服给药
- (4) 维持水电解质平衡，纠正酸碱失衡，当 $\text{pH} < 7.20$ 且合并代酸时，应适当补碱
- (5) 经过上述治疗，临床症状和肺功能无改善甚至继续恶化者，应及时给予机械通气治疗，其指征主要包括呼吸及疲劳、 $\text{PaCO}_2 \geq 45\text{mmHg}$ 、意识改变（需进行有创机械通气）
- (6) 预防呼吸道感染

支气管扩张

7、支气管扩张的治疗原则

- ①治疗基础疾病：对活动性肺结核伴支扩应积极抗结核治疗，低免疫球蛋白血症可用免疫球蛋白代替治疗
- ②控制感染：出现痰量及其脓性成分增加等急性感染征象时需应用抗生素
- ③改善气流受限：对气道高反应及可逆性气流受限者，可应用支气管舒张剂
- ④清除气道分泌物：化痰药物以及振动、拍背和体位引流等均有助于清除
- ⑤咯血：少量对症治疗或口服卡巴克洛，中等可给予垂体后叶素或酚妥拉明，大量可介入栓塞或手术
- ⑥外科治疗：若为局限性，充分内科治疗仍无效者，可考虑手术切除病变肺组织。
若大出血来自于增生的支气管动脉、经保守治疗不能缓解反复大咯血时，病变局限者也可考虑手术
- ⑦预防

肺炎

8、肺炎的分类

- (一) 解剖分类：大叶性肺炎：X线显示肺叶或肺段的实变阴影
小叶性肺炎：X线显示沿着肺纹理分布的不规则斑片状阴影，边缘密度浅而模糊，无实变征象，肺下叶常受累
间质性肺炎：X线显示一侧或两侧肺下部不规则阴影，可呈现磨玻璃样、网格状，其间可有小片肺不张阴影
- (二) 病因分类：细菌性肺炎、非典型病原体所致肺炎、病毒性肺炎、肺真菌病、其他病原体所致肺炎、理化因素所致的肺炎
- (三) 患病环境分类：社区获得性肺炎：在医院外患的感染性肺实质炎症，包括具有明确潜伏期的病原体感染而入院后在平均潜伏期内爆发的肺炎
医院获得性肺炎：患者入院时不存在、也不处于潜伏期，而入院 48 小时后在医

院（包括老年护理院、康复院等）内发生的肺炎

9、重症肺炎的标准

主要标准：①需要有创机械通气
②感染性休克需要血管收缩剂治疗

次要标准：①呼吸频率 ≥ 30 次/分
② $PaO_2/FiO_2 \leq 250$
③多肺叶浸润
④意识障碍或定向障碍
⑤ $BUN \geq 7\text{mmol/L}$
⑥ $WBC < 4.0 \times 10^9/L$
⑦血小板 $< 10.0 \times 10^9/L$
⑧体温 $< 36^\circ\text{C}$
⑨低血压，需要强力的液体复苏

符合1项主要标准或3项次要标准以上者可诊断为重症肺炎，需收入ICU治疗

结核病

10、结核病的分类

- ①原发型肺结核
- ②血行播散型肺结核：急性血行播散型肺结核
亚急性、慢性血行播散性肺结核
- ③继发型肺结核：浸润性肺结核
空洞性肺结核
结核球
干酪样肺炎
纤维空洞性肺结核
- ④结核性胸膜炎：
- ⑤其他肺外结核
- ⑥菌阴肺结核

11、结核病的化学治疗原则

早期、规律、全程、适量、联合。整个治疗方案分强化和巩固两个阶段。

- ①早期：对所有检出和确诊患者均应立即给予化学治疗。早期化学治疗有利于迅速发挥早期杀菌作用，促使病变吸收和减少传染性。
- ②规律：严格遵照医嘱要求规律用药，不漏服，不停药，以避免耐药性的产生。
- ③全程：保证完成规定的治疗期是提高治愈率和减少复发率的重要措施。
- ④适量：严格遵照适当的药物剂量用药，药物剂量过低不能达到有效的血浓度，影响疗效和易产生耐药性，剂量过大易发生药物毒副反应。
- ⑤联合：同时采用多种抗结核药物治疗，可提高疗效，同时通过交叉杀菌作用减少或防止耐药性的产生。

肺癌

12、肺癌的分类

（一）解剖学分类：中央型肺癌
周围型肺癌

（二）病理组织学分类：

- ①非小细胞肺癌：鳞癌、腺癌、大细胞癌、其他（腺鳞癌、类癌、肉瘤、唾液腺型癌）
- ②小细胞肺癌

13、肺癌的临床表现

(一) 原发肿瘤引起的症状和体征：

咳嗽、痰血或咯血、气短或喘鸣、发热、体重下降

(二) 肺外胸内扩展引起的症状和体征：

胸痛、声音嘶哑、咽下困难、胸水、上腔静脉阻塞综合征、Horner 综合征

(瞳孔缩小、眼裂变浅、上睑下垂、眼球内陷)

(三) 胸外扩展引起的症状和体征：

转移至中枢神经系统(颅内压增高)

转移至骨骼(骨痛、病理性骨折)

转移至腹部(胰腺炎症或黄疸)

转移至淋巴结(典型者转移至锁骨上淋巴结)

(四) 胸外表现——副瘤综合征：

肥大性肺性骨关节病、异位促性腺激素、分泌促肾上腺皮质激素样物、分泌抗利尿激素、神经肌肉综合征、高钙血症、类癌综合征

14、肺癌的辅助检查方法

①胸部 X 线影像学检查

②磁共振显像

③单电子发射计算机断层成像(SPECT)

④正电子发射计算机断层显像(PET)

⑤痰脱落细胞检查

⑥支气管镜检查

⑦针吸细胞学检查：浅表淋巴结针吸细胞学检查、经支气管镜针吸细胞学检查、经皮针吸细胞学检查

⑧纵隔镜检查

⑨胸腔镜检查

⑩其他组织或病理检查：开胸肺活检、肿瘤标志物检查

肺心病

15、肺心病的临床表现

本病发展缓慢，临床上除原有肺、胸疾病的各种症状和体征外，主要是逐步出现肺、心功能衰竭以及其他器官损害的征象。按其功能的代偿期与失代偿期进行分述。

(1)肺、心功能代偿期：

①症状：咳嗽、咳痰、气促，活动后可有心悸、呼吸困难、乏力和劳动耐力下降。

急性感染可使上述症状加重。少有胸痛或咯血。

②体征：发绀、肺气肿体征、干湿性啰音、 $P_2 > A_2$ 、三尖瓣区收缩期杂音、剑突下心搏增强、颈静脉充盈

(2)肺、心功能失代偿期：

(一)呼吸衰竭：

①症状：呼吸困难加重，夜间为甚，常有肺性脑病的表现

②体征：发绀，球结膜充血、水肿、颅内压升高

腱反射减弱或消失、病理反射阳性，周围血管扩张

(二)右心衰竭：

①症状：气促更明显，心悸、食欲不振、腹胀、恶心等

②体征：发绀、颈静脉怒张、剑突下收缩期、舒张期杂音、肝颈静脉回流征阳性、双下肢水肿

16、肺心病失代偿的治疗

治疗原则为积极控制感染，通畅呼吸道，改善呼吸功能，纠正缺氧和二氧化碳潴留、控制呼吸衰竭和心力衰竭，防止并发症

- ①控制感染：呼吸系统感染是引起慢性肺心病急性加重导致心肺功能失代偿的常见原因
- ②控制呼吸衰竭：扩张支气管、祛痰，通畅呼吸道，改善呼吸功能
- ③控制心力衰竭：经上述治疗无效者，可选用利尿药、正性肌力药、扩血管药
- ④防止并发症：肺性脑病、酸碱平衡及电解质紊乱、心律失常、休克、消化道出血、DIC、深静脉血栓形成
- ⑤护理

气胸

17、自发性气胸的临床类型及相应处理

临床类型：

- (1) 闭合性（单纯性）气胸
- (2) 交通性（开放性）气胸
- (3) 张力性（高压性）气胸

治疗：目的是促进患侧肺复张、消除病因、减少复发

- ①保守治疗：适用于稳定型小量气胸，首次发生的症状较轻的闭合性气胸，严格卧床休息、酌情予镇静、镇痛
- ②排气疗法：胸腔穿刺抽气：适用于小量气胸，呼吸困难较轻，心肺功能尚好的闭合性气胸
胸腔闭式引流：适用于不稳定型气胸，呼吸困难明显、肺压缩程度较重、交通性或张力性气胸、反复气胸发作者
- ③化学性胸膜固定术：适用于不宜手术或拒绝手术
- ④手术治疗：经内科治疗无效的气胸

18、气胸的并发症及其处理

- (1) 脓气胸：积极使用抗生素外，应插管引流，胸腔内生理盐水冲洗，必要时尚应根据具体情况考虑手术
- (2) 血气胸：肺完全复张后，出血多能自行停止，若继续出血不止，除抽气排液及适当输血外，应考虑开胸结扎出血的血管
- (3) 纵隔气肿与皮下气肿：皮下气肿及纵隔气肿随胸腔内气体排出减压而自行吸收。
吸入浓度较高的氧可增加纵隔内氧浓度，有利于气肿消散。
若纵隔气肿张力过高影响呼吸及循环，可作胸骨上窝切开排气。

呼衰

19、低氧血症和高碳酸血症的发生机制

- ①通气不足
- ②通气与血流比例失调
- ③动-静脉分流
- ④弥散障碍
- ⑤氧耗量增加

20、急性呼衰的治疗

- ①去除病因，保持呼吸道通畅（最基本、最重要）
- ②氧疗：在保证 PaO₂ 迅速提高到 66mmHg 或 SpO₂ 达 90%的前提下尽量减少吸氧浓度
I 型呼衰可较高浓度给氧，II 型呼衰往往需要低浓度持续给氧
- ③增加通气量、改善 CO₂ 潴留：呼吸兴奋剂（多沙普仑）、机械通气
- ④病因治疗
- ⑤一般支持疗法：维持电解质平衡、酸碱平衡
HCT 在一定水平
充足的营养和能量供给

21、慢性呼衰的治疗

- ①氧疗：低浓度吸氧
- ②机械通气
- ③控制感染
- ④呼吸兴奋剂：必要时用阿米三嗪
- ⑤纠正酸碱失衡

心衰

22、心力衰竭的分级（NYHA 级）

- I 级：患者患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。
- II 级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。
- III 级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起上述的症状。
- IV 级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

23、急性心力衰竭的治疗原则

- ①体位：患者取坐位，双腿下垂，以减少静脉回流
- ②吸氧：高流量鼻管吸氧，酒精抗泡沫给氧，可用无创呼吸机吸氧
- ③救治准备：静脉通道开放、留置导尿管、心电监护、经皮血氧饱和度检测
- ④镇静：吗啡 5-10mg 静脉注射，必要时 5-10min 重复一次，共 2-3 次
- ⑤快速利尿，速尿 20-40mg 静注，4h 后可重复 1 次
- ⑥氨茶碱
- ⑦洋地黄类药物：毛花苷 C 静脉给药最适用于有快速心室率的房颤并心室扩大伴左心室收缩不全者
- ⑧血管活性药物：血管扩张剂：硝普钠、硝酸酯类、α 受体拮抗剂
正性肌力药
- ⑨机械辅助治疗：主动脉内球囊反搏和临时心肺辅助系统
- ⑩病因治疗

心律失常

24、心律失常的分类

I、按其发生原理

(一)冲动形成异常：

窦性心律失常：①窦速 ②窦缓 ③窦律不齐 ④窦性停搏

异位心律：被动性异位心律：①逸搏（房性、房室交界区性、室性）

②逸搏心律（房性、房室交界区性、室性）

主动性异位心律：①期前收缩（房性、房室交界区性、室性）

②阵发性心动过速（房性、房室交界区性、房室折返性、室性）

③心房扑动、心房颤动

④心室扑动、心室颤动

(二)冲动传导异常：生理性：干扰及房室分离

病理性：①窦房传导阻滞

②房内传导阻滞

③房室传导阻滞

④束支或分支阻滞（左、右束支及左束支分支传导阻滞）或室内阻滞

房室间传导途径异常预激综合征

II、按照心律失常发生时心率的快慢，可将其分为快速性心律失常与缓慢性心律失常两大类

25、心律失常的发生机制

冲动形成异常：触发活动、异位起搏点的兴奋性增高

冲动传导异常：折返是快速心律失常的最常见发生机制。产生折返的基本条件是传导异常，包括：

①心脏两个或多个部位的传导性与不应期各不相同，相互连接形成一个闭合环；

②其中一条通道发生单向传导阻滞；

③另一通道传导缓慢，使原先发生阻滞的通道有足够时间恢复兴奋性；

④原先阻滞的通道再次激动，从而完成一次折返激动。

冲动在环内反复循环，产生持续而快速的心律失常

冠心病

冠心病的分型：隐匿型或无症状型冠心病、心绞痛、心肌梗死、缺血性心肌病、猝死

慢性冠脉病：稳定性心绞痛、缺血性心肌病、隐匿型心绞痛

急性冠脉综合症：不稳定心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死、ST 段抬高型心肌梗死

26、冠心病二级预防

已有冠心病和 MI 病史者还应预防再次梗死和其他心血管事件称之为二级预防，包括以下五方面：

①抗血小板聚集；抗心绞痛治疗，硝酸酯类制剂

②预防心律失常，减轻心脏负荷等；控制好血压

③控制血脂水平；戒烟

④控制饮食；治疗糖尿病

⑤普及有关冠心病的教育，包括患者及其家属；鼓励有计划的、适当的运动锻炼

稳定型心绞痛

27、稳定型心绞痛的症状

- (1) 部位：主要在胸骨体中段或上段之后，偶波及心前区，有手掌大小的范围，甚至横贯前胸，接线不很清楚。场放射至左肩左臂内侧达无名指和小指，或全颈，咽或下颌部。
- (2) 性质：胸痛常为压迫，发闷或紧缩性，也可有烧灼感，但不尖锐，不像针刺或刀扎样痛偶伴濒死的恐惧感。发作时，患者往往不自觉的停止原来的活动直至症状缓解。
- (3) 诱因：劳累、情绪激动、饱食受寒、急性循环衰竭等为常见诱因。
- (4) 持续时间：疼痛出现后常逐渐加重，然后再 3-5 分钟内消失，可数天或数星期发作一次，亦可一日内多次发作。
- (5) 缓解方式：一般在停止原来诱发病状的活动后即可缓解；舌下含用硝酸甘油也能在几分钟内使之缓解。

28、稳定型心绞痛的诊断（CCS 分级）

- I 级：一般体力活动不受限，仅在强、快或持续用力时发生心绞痛。
- II 级：一般体力活动轻度受限。快步、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛。一般情况下平地步行 200m 以上或登楼一层以上受限。
- III 级：一般体力活动明显受限，一般情况下平地步行 200m，或登楼一层引起心绞痛。
- IV 级：轻微活动或休息时即可发生心绞痛。

不稳定型心绞痛

29、不稳定型心绞痛的临床特点

- ①诱发心绞痛的体力活动阈值突然或持久降低
- ②心绞痛发生频率、严重程度和持续时间增加
- ③出现静息或夜间心绞痛
- ④胸痛放射至附近的或新的部位
- ⑤发作时伴有新的相关症状，如恶心、呕吐、心悸或呼吸困难
- ⑥常规休息或舌下含服硝酸甘油只能暂时甚至不能完全缓解症状

30、不稳定型心绞痛的治疗原则

治疗目的：即刻缓解缺血、预防严重不良反应后果

治疗：一般治疗：立刻卧床休息，消除紧张情绪和顾虑，保持环境安静

抗缺血治疗：硝酸酯类、BA、CCB

抗血小板治疗：阿司匹林、ADP 受体拮抗剂、血小板糖蛋白受体拮抗剂

抗凝治疗：普通肝素、低分子肝素、硫酸肝癸钠、比伐卢定

冠脉血运重建术：经皮冠脉介入治疗、冠脉旁路搭桥术

急性心肌梗死

31、何为泵衰竭？请按 Killip 分级？

急性心肌梗死引起的心力衰竭称为泵衰竭

分级：I 级尚无明确心力衰竭

II 级有左心衰竭，肺部啰音<50%肺野

III 级有急性肺水肿，全肺大、小、干、湿啰音

IV 级有心源性休克等不同程度或阶段的血液动力学变化

32、急性心肌梗死的诊断标准

确诊需符合下述3项标准中的2项:

- (1) 临床表现: 心前区绞痛: 持续性缺血性胸痛, 多发生于安静时, 休息和含用硝酸甘油多不缓解
全身症状: 发热、心动过速、白细胞增高、ESR 增高
胃肠道症状: 频繁恶心、呕吐、上腹胀痛
心率失常: 室性心律失常最常见, 尤其是室性期前收缩
低血压或休克
心力衰竭: 主要是急性左心衰竭
- (2) 心电图: ST 段弓背向上型抬高、病理性 Q 波、T 波倒置
- (3) 实验室检查: 肌红蛋白起病后2小时升高, 12小时内达高峰
肌钙蛋白 I 起病后3~4小时升高, 11~24小时达高峰, 7~10天降至正常
肌钙蛋白 T 起病后3~4小时升高, 24~48小时达高峰, 10~14天降至正常
肌酸激酶同工酶 CK-MB 起病后 4 小时内升高, 16~24 小时达高峰
心肌酶: CK、AST、LDH

33、心肌梗死的并发症

- ①乳头肌功能失调或断裂 (总发生率可达 50%)
- ②心脏破裂
- ③栓塞
- ④心室壁瘤
- ⑤心肌梗塞后综合症

34、心绞痛和急性心肌梗死的鉴别诊断要点

鉴别诊断项目	心绞痛	急性心肌梗死
疼痛		
1. 部位	中下段胸骨后	相同,但可在较低位置或上腹部
2. 性质	压榨性或窒息性	相似,但程度更剧烈
3. 诱因	劳力、情绪激动、受寒、饱食等	不常有
4. 时限	短,1~5 分钟或 15 分钟以内	长,数小时或 1~2 天
5. 频率	频繁	发作不频繁
6. 硝酸甘油疗效	显著缓解	作用较差或无效
气喘或肺水肿	极少	可有
血压	升高或无显著改变	可降低,甚至发生休克
心包摩擦音	无	可有
坏死物质吸收的表现		
1. 发热	无	常有
2. 血白细胞增加(嗜酸性粒细胞减少)	无	常有
3. 血沉增快	无	常有
4. 血清心肌坏死标记物升高	无	有
心电图变化	无变化或暂时性 ST 段和 T 波变化	有特征性和动态性变化

35、心肌梗死的治疗

治疗原则是尽快恢复心肌的血液灌注（到达医院后 30 分钟内开始溶栓或 90 分钟内开始介入治疗）以挽救濒死的心肌、防止梗死扩大或缩小心肌缺血范围，保护和维持心脏功能，及时处理严重心律失常、泵衰竭和各种并发症，防止猝死，使患者不但能渡过急性期，且康复后还能保持尽可能多的有功能的心肌。

- （一）监护和一般治疗：休息、监测、吸氧、护理、建立静脉通道
- （二）解除疼痛：心肌再灌注治疗开通梗死相关血管、恢复缺血心肌是解除疼痛的最有效的办法
 哌替啶或吗啡、硝酸甘油、B 受体拮抗剂
- （三）抗血小板治疗：阿司匹林、氯吡格雷
- （四）抗凝治疗
- （五）再灌注心肌治疗：PCI、溶栓疗法、紧急冠脉旁路搭桥术
- （六）ACEI
- （七）调脂治疗
- （八）抗心律失常和传导障碍治疗
- （九）抗休克治疗
- （十）抗心衰治疗
- （十一）右心室心梗治疗
- （十二）其他
- （十三）恢复期的处理

高血压

36、高血压的诊断

高血压诊断主要根据诊所测量的血压值，采用经核准的水银柱或电子血压计，测量安静休息坐位时上臂肱动脉部位血压，一般需非同日测量三次血压值收缩压均>140mmHg 和(或)舒张压均>90mmHg 可诊断高血压。

37、高血压的治疗

最终目的：减少高血压患者心、脑血管病的发生率和死亡率。

血压控制目标值：

至少<140/90mmHg

糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭或病情稳定的冠心病合并高血压患者，血压控制目标值<130/80mmHg

老年收缩期性高血压的降压目标水平，收缩压<150mmHg，如能耐受可降至 140mmHg 以下

用药原则：小剂量

 优先选择长效制剂

 联合用药

 个性化

38、降压药物的种类及代表药

- (1) 利尿剂：双氢克尿噻
- (2) β 手拮阻滞剂：倍他乐克
- (3) 钙通道阻滞剂：非洛地平，硝苯地平缓释片
- (4) 血管紧张素转换酶抑制剂：卡托普利，依那普利
- (5) 血管紧张素 II 手拮阻滞剂：厄贝沙坦

二尖瓣狭窄

39、二尖瓣狭窄的临床表现

(一)症状：(1)呼吸困难：最常见、最早期

(2)咳嗽

(3)咯血：大咯血：支气管静脉破裂出血

痰中带血或血痰：夜间阵发性呼吸困难

肺梗死时咳胶冻状暗红色痰

粉红色泡沫痰：急性肺水肿

(4)血栓栓塞

(5)声音嘶哑

(二)体征：(1)严重二狭体征：二尖瓣面容

(2)心音：如瓣叶柔顺有弹性，在心尖区可闻第一心音亢进、扑击样，开瓣音

如瓣叶钙化僵硬，则第一心音减弱，开瓣音消失

肺动脉高压时肺动脉瓣区第二心音亢进或伴分裂

(3)心脏杂音：心尖区低调的隆隆样递增型舒张中晚期杂音，局限，不传导，常伴舒张期震颤

Graham-Steel 杂音：相对性肺闭

胸骨左缘第 4、5 肋间闻及全收缩期吹风样杂音：相对性三闭

40、二尖瓣狭窄的并发症

(1)心房颤动：最常见、相对早期

(2)急性肺水肿：重度

(3)血栓栓塞：脑栓塞最常见

(4)右心衰竭：晚期常见

(5)感染性心内膜炎

(6)肺部感染

主动脉瓣狭窄

41、主动脉瓣关闭不全的临床表现

(1)症状：①急性轻者可无症状，重者出现呼吸困难，咳白色或粉红色泡沫痰

②慢性可多年无症状，甚至可耐受运动。

最先心悸、心前区不适、头部强烈搏动感等症状，晚期始出现左心室衰竭表现

(2)体征：①急性：面色灰暗，唇甲发绀，脉搏细数，血压下降

②慢性：(一)面色苍白，头随心搏摆动

(二)心音：第一心音减弱、A2 减弱或缺如、心尖区常有第三心音

心尖搏动：向左下移位，呈心尖抬举性搏动

(三)心脏杂音：高调叹气样递减型舒张早期杂音，坐位前倾和深呼气时易听到，

向心尖区传导

(四)周围血管征：点头征、水冲脉、枪击音、毛细血管搏动征、Duroziez 双重杂音

心包压塞

42、心包压塞的临床表现

典型临床症状为低血压、心音遥远、颈静脉怒张

①症状：呼吸困难是最突出症状，患者可呈端坐呼吸，身体前倾、呼吸浅速、面色苍白、发绀
也可有干咳、声音嘶哑、吞咽困难

②体征：心浊音界向两侧扩大、左肩胛骨下出现叩浊音，听诊闻及 Ewart 征、脉压减小、奇脉

③心脏压塞：急性心脏压塞：明显心动过速、血压下降、脉压变小和静脉压明显上升

心排量显著下降，可产生急性循环衰竭、休克等

亚急性或慢性心脏压塞：体循环静脉淤血，颈静脉怒张、静脉压升高、奇脉

奇脉是指大量积液患者在触诊时桡动脉搏动呈吸气性显著减弱或消失、呼气时复原

感染性心内膜炎

43、感染性心内膜炎 Duke 诊断标准

◆ 主要标准

(一) 血培养阳性(符合以下至少一项标准)

两次不同时间的血培养检出同一典型 IE 致病微生物(如草绿色链球菌,链球菌,金黄色葡萄球菌)

多次血培养检出同一 IE 致病微生物(2 次至少间隔 12 小时以上的血培养阳性;所有 3 次血培养均阳性、或 4 次或 4 次以上的多数血培养阳性)

Q 热病原体 1 次血培养阳性或其 IgG 抗体滴度>1:800

(二) 心内膜受累证据(符合以下至少一项标准)

超声心动图异常(赘生物、脓肿、人工瓣膜裂开)

新出现的瓣膜反流

◆ 次要标准

1. 易患因素:心脏本身存在易患因素,或静脉药物成瘾者

2. 发热:体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$

3. 血管征象:主要动脉栓塞,感染性肺梗死,细菌性动脉瘤,颅内出血,结膜出血,以及 Janeway 损害

4. 免疫性征象:肾小球肾炎,Osler 结节,Roth 斑以及类风湿因子阳性

5. 致病微生物感染证据:不符合主要标准的血培养阳性,或与 IE 一致的活动性致病微生物感染的血清学证据

确诊:满足 2 项主要标准,或 1 项主要标准+3 项次要标准,或 5 项次要标准

疑诊:满足 1 项主要标准+1 项次要标准,或 3 项次要标准

44、感染性心内膜炎的抗生素用药原则

(1) 早期应用，在连续送 3~5 次血培养后即可开始治疗

(2) 充分用药，选用杀菌性抗微生物药物，大剂量和长疗程，旨在完全消灭藏于赘生物内的致病菌

(3) 静脉用药为主，保持高而稳定的血药浓度

(4) 病原微生物不明时，急性者选用针对金黄色葡萄球菌、链球菌和革兰阴性杆菌均有效的广谱抗生素，
亚急性者选用针对大多数链球菌（包括肠球菌）的抗生素

(5) 已分离出病原微生物时，应根据致病微生物对药物的敏感程度选择抗微生物药物

消化性溃疡

45、消化性溃疡的并发症

- (1) 出血：出血是消化性溃疡最常见的并发症，也是上消化道大出血最常见的病因，轻者黑粪、重者呕血
- (2) 穿孔：溃疡病灶向深部发展，穿透胃、十二指肠壁，可有三种后果：
- ① 溃疡入腹腔引起弥漫性腹膜炎
 - ② 溃疡穿破并受阻于毗邻实质性器官，如肝、脾、胰（穿透性溃疡）
 - ③ 溃疡传入空腔器官形成瘘管
- (3) 幽门梗阻：主要是由球溃或幽门管溃疡引起，吐后缓解、呕隔夜宿食
- (4) 癌变：少数 GU 可发生癌变，DU 一般不发生

45、消化性溃疡的治疗

治疗的目的是消除病因、缓解症状、愈合溃疡、防止复发和防治并发症。

- (1) 药物治疗：抑制胃酸分泌：H₂RA、PPI

根除 Hp：1 种 PPI+2 种抗生素，或 1 种铋剂+2 种抗生素

保护胃黏膜：铋剂、弱碱性抗酸剂

- (2) 治疗消化性溃疡的方案及疗程：

抑酸药物疗程通常为 4~6w，部分 8w

根除 Hp 所需的 1~2w 可重叠在 4~8w 的抑酸药物疗程内，也可抑酸药物疗程结束后进行

- (3) 患者教育

- (4) 维持治疗：对反复溃疡复发、Hp 阴性及已除去其他危险因素的患者，可给予维持治疗

- (5) 外科手术

肠结核

46、肠结核与克罗恩病的鉴别

	肠结核	克罗恩病
肠外结核	多见	一般无
病程	复发不多	病程长,缓解与复发交替
瘘管、腹腔脓肿、肛周病变	少见	可见
病变节段性分布	常无	有
溃疡形状	常呈横行、浅表而不规则	多成纵行、裂隙状
结核菌素试验	强阳性	弱~阳性
抗结核治疗	症状改善,肠道病变好转	无明显改善,肠道病变无好转
组织病理抗酸杆菌	可有	无
干酪性肉芽肿	有	无

溃疡性结肠炎

47、溃疡性结肠炎的临床表现

- (1) 消化系统表现：①腹泻和黏液脓血便
②腹痛：里急后重、便后缓解
③腹胀，严重病例有食欲不振、恶心、呕吐
④体征：轻、中型患者仅有左下腹轻压痛，有时可触及痉挛的降结肠或乙状结肠；重型和暴发型患者常有明显压痛和鼓肠
- (2) 全身表现：发热：中、重型活动期常有低度至中度发热，高热多提示严重感染、并发症、急性进展
营养不良：重症、持续活动可出现衰弱、消瘦、贫血、低蛋白血症、水电解质平衡紊乱
- (3) 肠外表现：外周关节炎、结节红斑、坏疽性脓皮病、巩膜外层炎、前葡萄膜炎、口腔复发性溃疡
骶髂关节炎、强直性脊柱炎、原发性硬化性胆管炎、淀粉样变性、急性发热性嗜中性皮肤病

48、溃疡性结肠炎与结肠克罗恩病的鉴别

	UC	结肠 CD
症状	脓血便多见	脓血便较少见
病变分布	连续	节段性
直肠受累	绝大多数	少见
肠腔狭窄	少见, 中心性	多见、偏心性
溃疡及黏膜	溃疡浅, 黏膜弥漫性充血水肿、颗粒状, 脆性增加	纵行溃疡、黏膜呈卵石样, 病变间的黏膜正常
组织病理	固有膜全层弥漫性炎症、隐窝脓肿、隐窝结构明显异常、杯状细胞减少	裂隙状溃疡、非干酪性肉芽肿、黏膜下层淋巴细胞聚集

49、溃疡性结肠炎的治疗

治疗目的是控制急性发作，黏膜愈合，维持缓解，减少复发，防治并发症

- (1) 控制炎症反应：
①氨基水杨酸制剂：柳氮磺吡啶 (SASP) 是治疗本病的常用药物
②糖皮质激素：对急性发作期有较好疗效
③免疫抑制剂：硫唑嘌呤或巯嘌呤可试用于对激素治疗效果不佳或对激素依赖的慢性持续型病例
- (2) 对症治疗：对腹痛、腹泻的对症治疗，要权衡利弊，使用抗胆碱能药物或止泻药要慎重
- (3) 患者教育
- (4) 手术治疗：一般采用全结肠切除术加回结肠肛门小袋吻合术

肝硬化

50、肝硬化失代偿期的临床表现

- (1) 肝功能减退
①消化吸收不良
②营养不良
③黄疸
④出血和贫血
⑤内分泌失调：雌激素增多，雄激素减少；肾上腺皮质激素合成不足；抗利尿激素增多；T3、T4 降低
⑥不规则低热
⑦低白蛋白血症
- (2) 门静脉高压
①腹水
②门-腔侧支循环开放：食管胃底静脉、腹壁静脉、痔静脉、腹膜后吻合支曲张、脾肾分流
③脾功能亢进及脾大

51、肝硬化的并发症

- (1) 上消化道出血：食管胃底静脉曲张出血、消化性溃疡和急性出血性糜烂性胃炎、门脉高压性胃病
- (2) 胆石症
- (3) 感染：自发性细菌性腹膜炎、胆道感染、肺部、肠道及尿路感染
- (4) 门静脉血栓形成或海绵样变
- (5) 电解质和酸碱平衡紊乱
- (6) 肝肾综合征
- (7) 肝肺综合征
- (8) 原发性肝癌
- (9) 肝性脑病

52、肝硬化 Child—Pugh 分级标准

表 4-1-1 肝功 Child-Pugh 评分

观测指标	分数			分级	评分	1~2 年存活率(%)
	1	2	3			
肝性脑病(期)	无	I ~ II	III ~ IV	A	5 ~ 6	100 ~ 85
腹水	无	少	多	B	7 ~ 9	80 ~ 60
胆红素(μmol/L)	<34	34 ~ 51	>51	C	10 ~ 15	45 ~ 35
白蛋白(g/L)	>35	28 ~ 35	<28			
PT(>对照秒)	<4	4 ~ 6	>6			

肝硬化合并腹水

53、肝硬化合并腹水的机制

- (1) 门静脉高压，腹腔内脏血管床静水压增高，组织液回吸收减少而漏入腹腔，是腹水形成的决定因素
- (2) 有效循环血容量不足，肾血流减少，肾素-血管紧张素系统激活，肾小球滤过率降低，排钠和排尿量减少
- (3) 低白蛋白血症，白蛋白低于 30g/L 时，血浆胶体渗透压降低，毛细血管内液体漏入腹腔或组织间隙
- (4) 肝脏对醛固酮和抗利尿激素灭能作用减弱，导致继发性醛固酮增多和抗利尿激素增多；前者促钠重吸收，后者促水重吸收
- (5) 肝淋巴量超过了淋巴循环引流的能力，肝窦内压升高，肝淋巴液生成增多，自肝包膜表面漏入腹腔，参与腹水形成

54、肝硬化合并腹水的治疗原则

- ①限制钠、水的摄入：摄入钠盐 500~800mg/d，入水量<1000ml/d 左右
如有低钠血症，应限制在 500ml 以内
- ②利尿剂：联合应用保钾及排钾利尿剂，即螺内酯联合呋塞米
- ③经颈静脉肝内门体分流术（TIPS）：有效降低门静脉高压，甚至消除腹水
- ④排放腹水加输注白蛋白：顽固性腹水的姑息治疗
- ⑤自发性腹膜炎：选用肝毒性小、主要针对 G-杆菌并兼顾 G+的抗生素

原发性肝癌

55、原发性肝癌的转移途径

- (1) 肝内转移：肝癌最早在肝内转移，易侵犯门静脉及分支并形成癌栓，脱落后在肝内引起多发性转移灶。如门静脉干支有癌栓阻塞，可引起或加重原有门静脉高压，形成顽固性腹水。
- (2) 肝外转移：
 - ① 血行转移：最常见的转移部位为肺，因肝静脉中癌栓延至下腔静脉，经右心达肺动脉，在肺内形成转移灶。尚可引起胸、肾上腺、肾及骨等部位的转移。
 - ② 淋巴转移：转移至肝门淋巴结最为常见，也可转移至胰、脾、主动脉旁及锁骨上淋巴结。
 - ③ 种植转移：少见，从肝表面脱落的癌细胞可种植在腹膜、横膈、盆腔等处，引起血性腹水、胸水。女性可有卵巢转移癌。

56、原发性肝癌 AFP 的诊断标准

甲胎蛋白 AFP 是诊断肝细胞癌特异性标志物，广泛用于肝癌的普查、诊断、判断治疗效果及预测复发。在生殖腺胚胎瘤、少数转移性肿瘤、妊娠、活动性肝炎、肝硬化炎症活动期时，AFP 呈假阳性，但升高不如肝癌明显。

血清 AFP 浓度通常与肝癌大小呈正相关。

在排除妊娠、生殖腺胚胎瘤的基础上，血清 AFP 检查肝细胞癌的标准为：

- ① 大于 400 $\mu\text{g/L}$ ，持续 4 周以上；
- ② AFP 在 200 $\mu\text{g/L}$ 以上的中等水平，持续 8 周以上，应结合影像学及肝功能变化综合分析。
- ③ AFP 逐渐升而不降，应结合影像学及肝功能变化综合分析。

57、肝癌的诊断标准

- ① 具有两种典型影像学（US、增强 CT、MRI、选择性肝动脉造影）表现，病灶 $>2\text{cm}$ 。
- ② 一项典型影像学表现，病灶 $>2\text{cm}$ ，AFP $>400 \mu\text{g/L}$ 。
- ③ 肝脏活检阳性。

肝性脑病

58、肝性脑病的临床表现

主要表现为高级神经中枢的功能紊乱以及运动和反射异常，其临床过程现分为 5 期：

- 0 期（潜伏期）：又称轻微肝性脑病，无行为、性格的异常，无神经系统病理征，脑电图正常，只在心理测试或智力测试时有轻微异常。
- 1 期（前驱期）：轻度性格改变和精神异常，如焦虑、欣快激动、淡漠、睡眠倒错、健忘等，可有扑翼样震颤，脑电图多数正常。此期临床表现不明显，易被忽略。
- 2 期（昏迷前期）：嗜睡、行为异常（如衣冠不整或随地大小便）、言语不清、书写障碍及定向力障碍。有腱反射亢进、肌张力增高、踝阵挛及 Babinski 征阳性等神经体征，有扑翼样震颤，脑电图有特征性异常。
- 3 期（昏睡期）：昏睡，但可唤醒，醒时尚能应答，常有神志不清或幻觉，各种神经体征持续或加重，有扑翼样震颤，肌张力高，腱反射亢进，锥体束征常阳性，脑电图有异常波形。
- 4 期（昏迷期）：昏迷，不能唤醒。由于患者不能合作，扑翼样震颤无法引出。浅昏迷时，腱反射和肌张力仍亢进；深昏迷时，各种反射消失，肌张力降低。脑电图明显异常。

急性胰腺炎

59、急性胰腺炎的局部并发症

- (1) 瘘管：急性胰腺炎致胰管破裂，胰液从胰管漏出>7d
- (2) 假性囊肿：常在 SAP 病后 4 周左右出现，初期为液体积聚，无明显囊壁，此后由肉芽、纤维组织构成的囊壁缺乏上皮细胞，囊内无菌生长，含有胰酶
- (3) 胰腺脓肿：胰腺内、胰周积液、胰腺假性脓肿感染，发展为脓肿，伴发热、腹痛、消瘦、营养不良

60、SAP 的症状、体征及相应的病理生理改变

表 4-18-1 重症急性胰腺炎的症状、体征及相应的病理生理改变

症状及体征	病理生理改变
低血压、休克	大量炎性渗出、严重炎症反应及感染
全腹膨隆、张力较高，广泛压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音少而弱，甚至消失；少数患者可有 Grey-Turner 征，Cullen 征	肠麻痹、腹膜炎、腹腔间隔室综合征、胰腺出血坏死
呼吸困难	肺间质水肿、成人呼吸窘迫综合征、胸水、严重肠麻痹及腹膜炎
少尿、无尿	休克、肾功能不全
黄疸加深	胆总管下端梗阻、肝损伤
上消化道出血	应激性溃疡
意识障碍，精神失常	胰性脑病
体温持续升高或不降	严重炎症反应及感染
猝死	严重心律失常

61、诊断急性胰腺炎的重要标志物

- (1) 淀粉酶：血清淀粉酶起病后 2~12 小时开始升高，48 小时开始下降，持续 3~5 天
当患者无急腹症而有血清淀粉酶升高时，应考虑来源于唾液腺
胰源性胸、腹水、胰腺假性囊肿中的淀粉酶常明显升高
- (2) 脂肪酶：血清淀粉酶起病后 24~72 小时开始升高，持续 7~10 天
上述两种血清胰酶超过正常值 3 倍，才可诊断为急性胰腺炎
但血清胰酶的高低与病情程度无确切关联
胆石症、胆囊炎、消化性溃疡等急腹症时，上述两种血清胰酶也可升高，但低于正常值的 2 倍

62、急性胰腺炎的治疗措施

两大任务：寻找并去除病因、控制炎症

- ① 监护：密切观察体温、呼吸、脉搏、血压和尿量
- ② 器官支持：液体复苏、呼吸功能支持、肠功能维护、连续性血液净化
- ③ 减少胰液分泌：禁食、抑制胃酸、生长抑素及其类似物
- ④ 镇痛：可肌注哌替啶止痛，禁用吗啡、阿托品
- ⑤ 急诊内镜或外科手术去除病因
- ⑥ 预防和抗感染：选择针对 G-菌和厌氧菌、能透过血胰屏障的抗生素
- ⑦ 营养支持：病情缓解后，过渡到肠内营养
- ⑧ 择期内镜、腹腔镜或手术去除病因
- ⑨ 胰腺局部并发症：胰腺和胰周坏死组织继发感染、腹腔间隔室综合征、胰腺假性囊肿
- ⑩ 患者教育

上消化道出血

63、消化道出血临床表现

- ①呕血与黑便：上消化道出血特征；呕血多呈咖啡渣样；黑粪呈柏油样，粘稠而发亮
- ②血便及暗红色大便：中、下消化道出血表现，一般不伴呕血
上消化道出血亦可表现为暗红、鲜红色大便
- ③失血性周围循环衰竭：一般为头昏、心慌、乏力，突然起立
- ④贫血及血象变化：出血后，早期无明显变化，3~4h 后才出现贫血，24~72h 稀释到最大限度。
急性出血为正细胞正色素性贫血，慢性出血则为小细胞低色素性贫血
出血 24 小时内网织红细胞即可增高
- ⑤发热：部分患者 24h 内出现低热，持续 3~5 天后正常
- ⑥氮质血症：一般出血后数小时血尿素氮增加开始上升，约 24~48h 到达高峰，大多不超过 14.3mmol/L，3~4 日后恢复正常

64、出血程度的评估和周围循环状态的判断

- ①成人每日消化道出血>5~10ml 粪便隐血试验阳性
- ②每日出血量 50~100ml 可出现黑粪
- ③胃内储积血量>250ml 可引起呕血
- ④一次出血量不超过 400ml 时，因轻度血容量减少可由组织液及脾脏贮血所补充，多不引起全身症状
- ⑤出血量超过 400~500ml，可出现全身症状，如头昏、心慌、乏力等
- ⑥短时间内出血量超过 1000ml，可出现周围循环衰竭表现

65、上消化道大出血是否停止的判断

- 由于肠道内积血需经数日（一般约3日）才能排尽，故不能以黑粪作为继续出血的指标
活动性肠道出血的指征：
- ①反复呕血、或黑粪次数增多、粪质稀薄、肠鸣音活跃
 - ②周围循环状态经充分补液输血而未见明显改善，或虽暂时好转而又继续恶化
 - ③血红蛋白浓度、红细胞计数与红细胞比容继续下降，网织红细胞计数持续增高
 - ④补液与尿量足够的情况下，血尿素氮持续或再次增高

66、食管胃底静脉曲张出血的止血措施

- (1) 药物止血：尽早给予血管活性药物，如生长抑素、奥曲肽、垂体加压素，减少门静脉血流，降低门静脉压，从而止血
- (2) 内镜治疗：中量以下出血，应紧急采用 EVL 或内镜直视下注射液态栓塞胶至曲张静脉
- (3) 经颈静脉肝内门体静脉分流术：大出血及估计内镜治疗成功率低的患者应在 72 小时内行 TIPS
- (4) 气囊压迫止血：经鼻腔插入三腔二囊管，充气入胃囊(囊内压 50~70mmHg)，向外加压牵引，用以压迫胃底，若未能止血，再充气入食管囊(囊内压为 35~45mmHg)，压迫食管曲张静脉，一般持续压迫时间不应超过 24 小时

67、非静脉曲张出血的止血措施

以消化道溃疡出血所致出血最为常见

- (1) 抑制胃酸分泌：血小板聚集及血浆凝血功能所诱导的止血作用需在 pH>6.0 时才能有效发挥，而且新形成的凝血块在 pH<5.0 的胃液中会迅速被消化抑制胃酸分泌，故提高胃内 pH 值具有止血作用，常用 PPI 或 H2RA
- (2) 内镜治疗：内镜如见有活动性出血或暴露血管的溃疡应进行内镜止血
- (3) 介入治疗：内镜治疗不成功时，可通过血管介入栓塞胃十二指肠动脉
- (4) 手术治疗：药物、内镜及介入治疗仍不能止血、持续出血将危及患者生命时，须不失时机进行手术